

# Consentimiento informado: telemedicina y seguimiento remoto

Información y decisión individual | No es una autorización global de todas las técnicas

## 1. Identificación y alcance que se explicará

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Paciente y dos identificadores                 |  |
| Fecha, hora y episodio                         |  |
| Intervención, región y profesional responsable |  |
| Apoyos o representante cuando corresponda      |  |

## 2. Naturaleza de la intervención

Atención remota con categoría, plataforma, participantes y alcance descritos.

## 3. Finalidad y beneficios esperados

Se busca un objetivo funcional individual que se debe registrar y explicar antes de intervenir. Los resultados dependen de la condición, evolución y respuesta; no se garantiza curación ni un resultado por número de sesiones. El paciente puede elegir alternativas o aplazar.

## 4. Condiciones previas

El profesional revisará indicación, antecedentes, medicamentos relevantes, restricciones, competencia, equipos e insumos y privacidad. El consentimiento no suplente contraindicación, falta de recursos o modalidad no habilitada. Si no es seguro realizar, se modifica el plan o se remite.

## Riesgos, alternativas y comprensión

### 5. Riesgos y precauciones específicos

Limitación del examen, falla de conexión, exposición de datos o lesión en actividad sin apoyo. No se graba automáticamente y se acuerda ruta ante alarma o desconexión.

Los riesgos personales deben completarse según antecedentes, región y técnica exacta. Informar consecuencias relevantes y precauciones y revisar las advertencias del fabricante cuando hay dispositivo; no usar esta descripción general como sustituto de información individual.

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Riesgos particulares y antecedentes relevantes |  |
| Precauciones y límites acordados               |  |

### 6. Alternativas razonables

Atención presencial, canal accesible alternativo, apoyo adicional o aplazamiento.

También se explica la opción de no intervenir y las consecuencias previsibles de esa decisión. Ninguna alternativa se presenta para presionar al paciente ni como renuncia a derechos.

### 7. Comprensión, autonomía y preguntas

La información debe ser clara y accesible. Se ofrecen apoyos de comunicación y tiempo para decidir; discapacidad o edad avanzada no implican incapacidad. En menores aplicar autonomía progresiva, riesgo y habilidades conforme a Resolución 309 de 2025, con representación o consentimiento sustituto cuando proceden, y registro de asentimiento. No exigir representante a toda decisión adolescente sin valorar el caso.

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Preguntas y respuestas realmente ofrecidas |  |
| Comprensión expresada y apoyo utilizado    |  |

# Decisión voluntaria y soporte válido

## 8. Declaración de la persona que decide

He recibido información sobre la intervención y su alcance, finalidad, riesgos y alternativas. Tuve oportunidad de preguntar y recibí respuestas comprensibles. Mi decisión es libre y puedo no aceptar, aplazar o retirar mi autorización. Conozco que puedo solicitar detener el contacto o técnica durante la sesión y recibir orientación sobre continuidad.

No se incluyen exoneraciones de responsabilidad ni permisos publicitarios. Esta decisión se limita a la intervención y región registradas. Datos personales, imágenes y grabación se autorizan por finalidad y documento separados cuando la ley lo exige.

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Decisión: acepto / no acepto / aplazo / retiro      |  |
| Intervención, contacto y región autorizados         |  |
| Límites expresados por la persona                   |  |
| Fecha y hora de la decisión                         |  |
| Persona que decide e identidad                      |  |
| Representación o apoyos y fundamento si corresponde |  |
| Soporte válido de aceptación y ubicación            |  |
| Profesional que informó y soporte de autenticación  |  |
| Conducta y continuidad ofrecidas                    |  |

Este PDF no incorpora casillas de firma por el criterio previo de formatos sin firmas. Antes de usar, integrar firma o mecanismo legalmente válido de aceptación y autoría, según el caso y el medio. Nombre digitado o casilla aislada no los reemplazan. Sin ese soporte no presentar el consentimiento como completo.

# Cuidados, retiro y control del proceso

## 9. Recomendaciones y señales de alarma

Completar las indicaciones particulares de la técnica, signos que obligan a suspender, cuándo y dónde consultar y canal comprobado. No entregar un teléfono ficticio o afirmar que siempre habrá respuesta inmediata. Ante deterioro importante se orienta la atención urgente pertinente.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Cuidados individuales y actividad permitida |  |
| Síntomas de alarma propios de la técnica    |  |
| Destino y canal de atención comprobado      |  |
| Fecha o condición de seguimiento            |  |

## 10. Retiro o cambio posterior

Si cambia la técnica, región, riesgo o decisión, volver a informar y documentar. Conservar la decisión original y el registro de retiro o cambio con fecha, hora y soporte válido. No borrar la aceptación anterior ni continuar por una autorización general cuando el paciente pide detener.

## 11. Comprobación previa al uso

| Control                                        | Resultado real / evidencia |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Identidad y capacidad o apoyos evaluados       |                            |
| Intervención y riesgos individuales explicados |                            |
| Alternativas y comprensión documentadas        |                            |
| Decisión voluntaria y soporte válido           |                            |
| Cuidados, reserva y continuidad definidos      |                            |

## 12. Fuentes aplicables

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

Resolución 309 de 2025: información, participación, autonomía progresiva y contextual, consentimiento y asentimiento de niños, niñas y

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576